

## PANCREATITIS AGUDA

*Cristina Ferrero Sanz, Diana João Matias, Laura Rodríguez Martín.*

### INTRODUCCIÓN

Inflamación aguda del parénquima pancreático que puede condicionar morbimortalidad significativa por afectación peripancreática y/o sistémica. Las causas más frecuentes en nuestro medio son la biliar y alcohólica (90%).

### DIAGNÓSTICO

Fundamentalmente clínico y se confirman con pruebas complementarias. Para el diagnóstico se requiere dos de tres criterios:

- Dolor abdominal con clínica compatible con pancreatitis aguda.
- Enzimas (lipasa y amilasa) aumentadas más de 3 veces el límite superior de la normalidad.
- Prueba de imagen compatible con pancreatitis: TAC con contraste intravenoso compatible con pancreatitis.

### Síntomas

El síntoma mas frecuente es el dolor abdominal de inicio súbito, localizado en hemiabdomen superior (fundamentalmente en epigastrio irradiado a ambos hipocondrios y espalda en forma de cinturón). El dolor abdominal aumenta con la ingesta de alimentos y el decúbito, se alivia al sentarse en semiflexión. Puede presentar nauseas y vómitos que no alivian el dolor.

Un 5-10% de pacientes (adultos/ancianos, diabéticos, pacientes postoperados, en diálisis peritoneal, infecciones por legionella) no suelen presentar dolor abdominal. Existen dos fases en la pancreatitis.

**Fase aguda:** dura aproximadamente la primera semana, se caracteriza por efectos sistémicos secundarios a inflamación del páncreas, clínicamente se identifica un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

**Fase tardía:** dura semanas o meses, lo presentan los pacientes con pancreatitis moderada o grave, persiste signos sistémicos de inflamación.

Los síntomas principales son:

- Dolor en hemiabdomen superior a predominio epigastrio, dolor continuo irradiado en cinturón hacia la espalda.
- Náuseas y vómitos.
- Disnea, agitación e inquietud. Síntomas de afectación sistémica pueden estar presentes.

### Exploración física

Los hallazgos dependerán del tiempo de evolución y la gravedad, puede haber signos sistémicos: taquipnea secundaria a distres respiratorio o derrame pleural, taquicardia, fiebre, pudiendo llegar al shock y coma.

A la exploración abdominal dolor intenso a la palpación superficial y defensa a la palpación profunda, disminución de ruidos hidroaéreos. Puede existir ictericia obstructiva secundaria a coledocolitiasis o por compresión extrínseca del colédoco. En la exploración del tórax podemos encontrar crepitantes y disminución del murmullo vesicular a predominio de bases por presencia de derrame pleural o atelectasias.

Los signos tardíos de pancreatitis:

**Signo de Grey -Turner:** equimosis cutánea en la región lumbar/flancos por extensión del hematoma retroperitoneal, indica una gran extensión y varios días de evolución.

**Signo de Cullen:** se aprecia equimosis periumbilical, debido a la extensión de un hematoma de pancreatitis aguda necrohemorrágica, a través del ligamento redondo del hígado.

#### Pruebas complementarias

- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitario.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, LDH, GOT, GPT, amilasa, lipasa, bilirrubina total y fraccionada, PCR, procalcitonina, CK, Ckmb, Troponina Ultrasensible.
- **Coagulación.**
- **Gasometría arterial.** Si  $\text{SatO}_2 < 95\%$
- **Radiografía de abdomen.** descarta presencia de íleo, dilatación de asas.
- **Ecografía abdominal.** Descartar causa obstructiva de origen biliar.
- **TAC abdominal.** Ante la duda surgida tras realizar la ecografía abdominal o pancreatitis grave.

#### Clasificación

|                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pancreatitis aguda edematosa/intersticial</b> | Representa el 85% de los pacientes, tiene una mortalidad del 3%. Inflamación aguda del páncreas y tejido peripancreático, no existe necrosis. |
| <b>Pancreatitis aguda necrotizante</b>           | Representa el 15% de los pacientes, tiene una mortalidad del 17%. Existe una necrosis del parénquima pancreático y/o peripancreáticos.        |

#### **Clasificación de la pancreatitis de acuerdo a su gravedad, según los criterios de ATLANTA 2012**

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pancreatitis aguda (PA) leve</b>            | <b>No</b> tiene complicaciones locales o sistémicas, no presenta fallo orgánico. Tiene buena evolución y pronóstico.                                  |
| <b>Pancreatitis aguda moderadamente severa</b> | <b>Si</b> tiene complicaciones locales o sistémicas y/o <b>fallo orgánico transitorio</b> (<48 horas). Tiene pronóstico intermedio entre leve y grave |
| <b>Pancreatitis aguda severa</b>               | <b>Persistente.</b> Presenta fallo orgánico persistente (>48 horas). Se asocia a aumento de mortalidad hasta 50% de los casos.                        |

**PA Leve:** no presenta complicaciones locales, ni sistémicas, ni fallo orgánico.

**PA moderadamente grave:** presenta complicaciones locales o sistémicas y/o fallo orgánico transitorio.

**PA grave:** presenta fallo orgánico persistente.

#### Definición de fallo orgánico.

Se usa la escala de puntuación de **MARSHALL MODIFICADA**, valora tres sistemas:

**cardiovascular, renal y respiratorio.** El **fallo orgánico** se define con una puntuación  $\geq 2$  de cualquiera de los sistemas valorados.

| Sistema/órgano                                            | 0     | 1                          | 2                             | 3                | 4                |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| RESPIRATORIO<br>(PaO <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> )     | > 400 | 301-400                    | 201-300                       | 101-200          | < 101            |
| RENAL (creatinina<br>sérica, mg/dl)                       | < 1,4 | 1,4 - 1,8                  | 1,9 - 3,6                     | 3,6 - 4,9        | > 4,9            |
| CARDIOVASCULAR<br>(tensión arterial<br>sistólica en mmHg) | > 90  | < 90<br>Responde a fluidos | < 90<br>No responde a fluidos | < 90<br>pH < 7,3 | < 90<br>pH < 7,2 |

### Valoración de la gravedad.

Las primeras 12-24h son fundamentales para valorar la evolución de la gravedad de la pancreatitis aguda, en este periodo se produce la mayor incidencia de disfunción orgánica. El manejo de la pancreatitis aguda se basa en una correcta valoración clínica, factores de riesgo, presencia de SRIS y signos de hipovolemia: urea >43mg/dl, creatinina >1,8mg/dl, BUN > 20 y hematocrito >44%. Si aumentan estos parámetros o persistencia de SRIS en las primeras 24 - 48 horas, habiendo recibido adecuada sueroterapia IV son predictores de gravedad hacia una pancreatitis aguda grave.

### Factores de riesgo para pancreatitis grave.

- Edad > 60 años.
- Insuficiencia cardíaca.
- Insuficiencia renal crónica.
- Hepatopatía crónica.
- Neoplasia.
- Alcoholismo.
- Obesidad: IMC > 30kg/m<sup>2</sup>.

### Complicaciones

- Seudoquistes.
- Infecciones.
- Problemas respiratorios.
- Diabetes.
- Insuficiencia renal, hepática, cardíaca.
- Desnutrición.
- Cáncer de páncreas.

### Escalas de gravedad

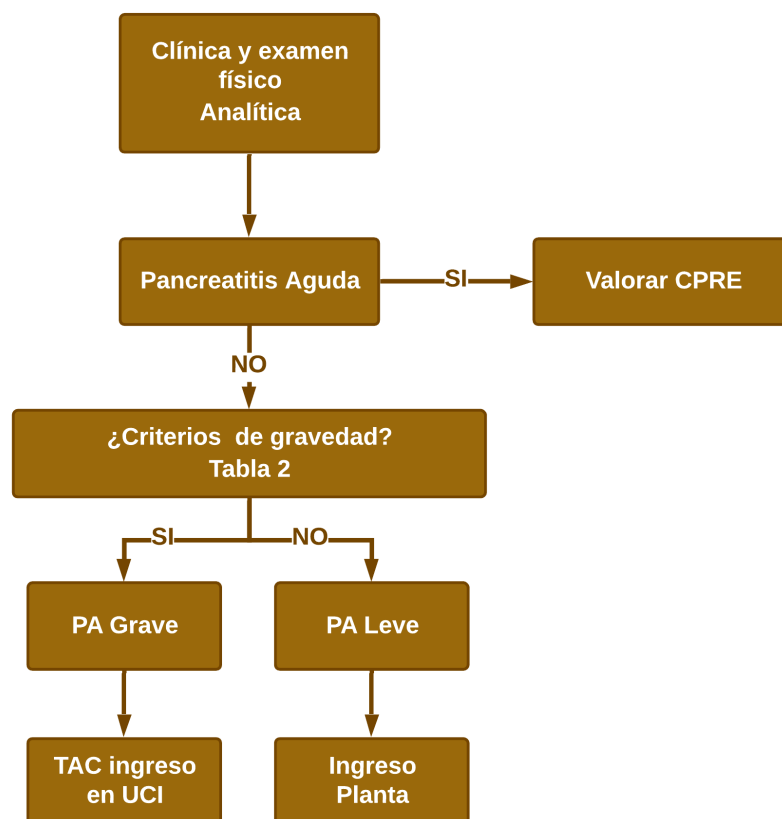
#### **APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation).**

Se aplica durante las primeras 24 horas, de uso en UCI preferentemente. Es uno de los sistemas de clasificación de severidad o gravedad. Consiste en detectar los trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del paciente, la determinación de las alteraciones de variables fisiológicas y de parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un factor predictivo de mortalidad. Los parámetros a determinar son:

- Temperatura del cuerpo.
- Presión arterial media (PAM).
- Frecuencia cardíaca.
- Frecuencia respiratoria.
- Oxigenación.
- pH arterial.
- Sodio plasmático (Na).
- Potasio plasmático (K).
- Creatinina.
- Hematocrito.
- Recuento de Leucocitos.
- Escala de Coma de Glasgow (GCS).

### Criterios de RANSON

| Criterios             | Pancreatitis aguda no biliar | Pancreatitis aguda biliar |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Al ingreso            |                              |                           |
| Edad                  |                              |                           |
| Leucocitos            |                              |                           |
| Glucosa               |                              |                           |
| GOT (AST)             |                              |                           |
| A las 48 horas        |                              |                           |
| Disminución del Hto.  |                              |                           |
| Aumento de la urea    |                              |                           |
| Calcemia              |                              |                           |
| PaO2                  |                              |                           |
| Déficit de bases      |                              |                           |
| Secuestro de líquidos |                              |                           |



**Tabla 2. Criterios de gravedad PA**

- Edad >60 años
- Obesidad: IMC >30kg/m<sup>2</sup>
- Analíticos: leucocitosis>16.000, LDH>600, glucosa>200, GOT>250, Urea>60, PCR>150
- Alteración nivel de conciencia
- Derrame pleural
- Fallo orgánico
- pO<sub>2</sub><60
- Creatinina>2mg/dl
- Shock (TAS<90, FC>130)
- Hemorragia digestiva

Una vez ingresado se debería llevar a cabo la clasificación de gravedad según las escalas de riesgo establecidas (Ranson, APACHE).

## TRATAMIENTO

- Dieta absoluta.
- Control de constantes vitales: TA, FC, FR, T<sup>a</sup>, con SatO<sub>2</sub> y balance hídrico (control de diuresis).
- Fluidoterapia amplia en las 12 -24h, se usara cristaloideos de elección (3500-4000cc/24h. Ajustar si cardiopatía/ICC, insuficiencia renal, ancianos). Añadir 20 mEq ClK ajustado a función renal, cada 8h IV (60mEq en 24h). Controlar la fluidoterapia con objetivo evitar la sobrecarga de volumen que puede desencadenar un síndrome compartimental abdominal.
- Colocación de sonda nasogástrica si íleo parálítico.
- Oxígeno: si SatO<sub>2</sub>< 95% en gafas nasales o ventimax según necesidad.
- Analgesia / antieméticos si precisa según escalón analgésico que necesite el paciente para controlar el dolor: Metamizol 1amp iv/8h iv: Tramadol 1 amp iv/6-8h: Meperidina 1 amp iv/ 6-8h, su inconveniente es su vida media corta y necesidad de dosis repetidas (precaución por

acumulo de normeperidina metabolito neurotóxico de la meperidina, que puede provocar convulsiones especialmente en ancianos, insuficiencia renal o hepática). Fentanilo por su perfil de seguridad en pacientes nefropatas. Metoclopramida 1 amp iv si precisa.

- Profilaxis de hemorragia digestiva: Pantoprazol 1 amp /24h iv.
- Profilaxis antibiótica (sólo en casos de pancreatitis necrotizante o datos de gravedad): Meropenem 500mg /8h iv.

## BIBLIOGRAFÍA

- M.A. Montoro Huguet; JC. García Pagán. Practica clínica en Gastroenterología y Hepatología. Vol II. 1ª ed. Madrid. CTO editorial. 2016. Cap. 53 y 57.
- American College of gastroenterology guideline: Management of acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108: 1400-15;1416.
- F. Aguilar Rodriguez; O. Bisbal Prado; C. Gómez Cuervo; M. de Lagarde Sebastián; G. Maestro de la Calle; M. A. Pérez-Jacoiste Asín; J. Llenas García; L. Pérez Ordoño; J. Villa Santos. Manual diagnóstico y terapéutica médica 12 de Octubre. 8ªEd. Madrid. MSD. 2016. Cap. 51 y 58.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez F.J. Medicina de Urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. Barcelona. 6ª edición. Editorial Elsevier. 2018.